# LAPORAN PRAKTIKUM
# ENTERPRISE ARCHITECTURE

## MODUL 5
### Arsitektur Bisnis (Fase B)

Studi Kasus: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur


**Disusun oleh:**

Farhana Wahidiyah (20240803091)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG**

## A. Tujuan

Praktikum ini bertujuan untuk menyusun Business Capability Map dan Value Stream, memodelkan satu proses bisnis inti dengan BPMN, serta menyusun katalog organisasi dan layanan bisnis untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.

## B. Hasil Kerja

### 1. Business Capability Map

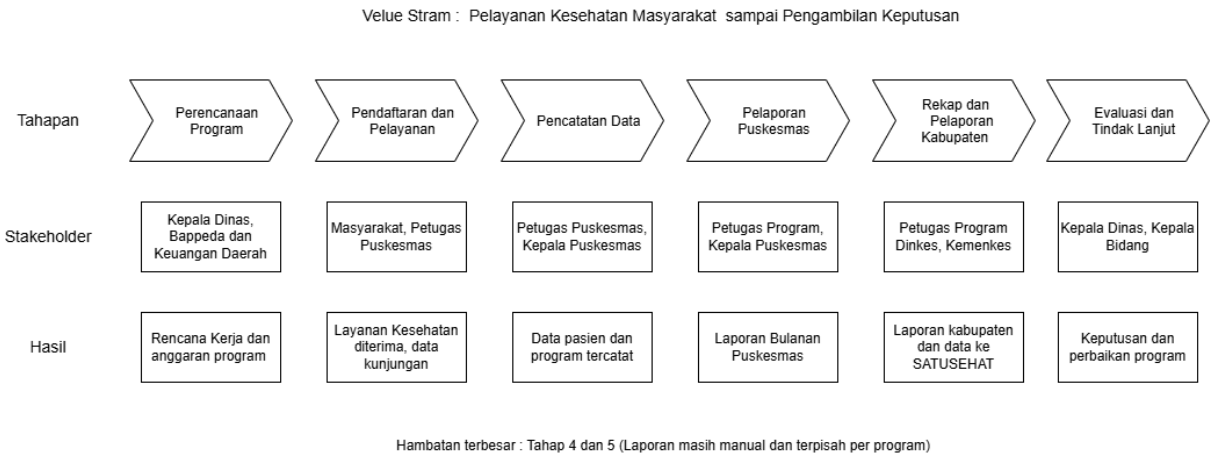
Capability disusun tiga tingkat: L1 berupa kategori, L2 berupa capability, dan L3 berupa sub-capability. Pengelompokannya mengikuti tugas Dinas Kesehatan dan hasil Modul 1 sampai 4. Tingkat kematangan dinilai dari kondisi yang sudah ditemukan sebelumnya (skala 1 = ad-hoc sampai 5 = optimal), sedangkan prioritas investasi dinilai dari seberapa penting capability itu bagi tujuan strategis dinas.

**Tabel 5.1 Business Capability Map**

| Kategori (L1) | Capability (L2) | Sub-capability (L3) | Kematangan (1-5) | Prioritas investasi |
|---|---|---|---|---|
| Perencanaan dan Tata Kelola | Perencanaan Program dan Anggaran | Penyusunan Renstra dan Renja, penyusunan RKA/DPA | 3 | Sedang |
| Perencanaan dan Tata Kelola | Pemantauan dan Evaluasi Kinerja | Pemantauan indikator SPM, evaluasi program | 2 | Tinggi |
| Perencanaan dan Tata Kelola | Tata Kelola TI dan Arsitektur | Kebijakan TI, pengelolaan arsitektur | 1 | Tinggi |
| Pelayanan Kesehatan | Pendaftaran dan Pelayanan Pasien | Pendaftaran pasien, pemeriksaan dan pencatatan, rujukan | 3 | Tinggi |
| Pelayanan Kesehatan | Rekam Medis Elektronik (RME) | Pencatatan RME, pengiriman ke SATUSEHAT | 2 | Tinggi |
| Pelayanan Kesehatan | Jaminan Kesehatan Daerah | Verifikasi kepesertaan, pelaporan klaim Jamkesda | 2 | Sedang |
| Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Penyakit | Penanganan Stunting dan Gizi | Pencatatan data balita, pemantauan status gizi | 2 | Tinggi |
| Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Penyakit | Imunisasi | Pencatatan imunisasi, pemantauan cakupan | 2 | Tinggi |
| Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Penyakit | Pengendalian Penyakit Menular | Pengamatan penyakit (DBD), penanganan KLB | 2 | Tinggi |
| Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Penyakit | Pelaporan Program Kesehatan | Rekap laporan Puskesmas, pelaporan ke Kemenkes | 1 | Tinggi |
| Sumber Daya Kesehatan | Pengelolaan Obat dan Alkes | Perencanaan kebutuhan, stok gudang farmasi, distribusi ke Puskesmas | 2 | Sedang |
| Sumber Daya Kesehatan | Pengelolaan Tenaga Kesehatan | Data tenaga kesehatan, pelatihan | 2 | Sedang |

| Kategori (L1) | Capability (L2) | Sub-capability (L3) | Kematangan (1-5) | Prioritas investasi |
|---|---|---|---|---|
| Sumber Daya Kesehatan | Pengelolaan Fasilitas Kesehatan | Data Puskesmas dan Posyandu, perizinan | 3 | Rendah |
| Pengelolaan Data dan TI | Manajemen Data Kesehatan | Standar dan kamus data, data induk | 1 | Tinggi |
| Pengelolaan Data dan TI | Integrasi dan Interoperabilitas | SSO, API, koneksi ke SATUSEHAT | 1 | Tinggi |
| Pengelolaan Data dan TI | Infrastruktur dan Keamanan | Jaringan, server dan backup, keamanan data | 2 | Tinggi |
| Dukungan Manajemen | Keuangan dan Anggaran | Pengelolaan anggaran, pertanggungjawaban keuangan | 3 | Rendah |
| Dukungan Manajemen | Kepegawaian dan Umum | Administrasi pegawai, surat menyurat | 3 | Rendah |

## 2. Value Stream

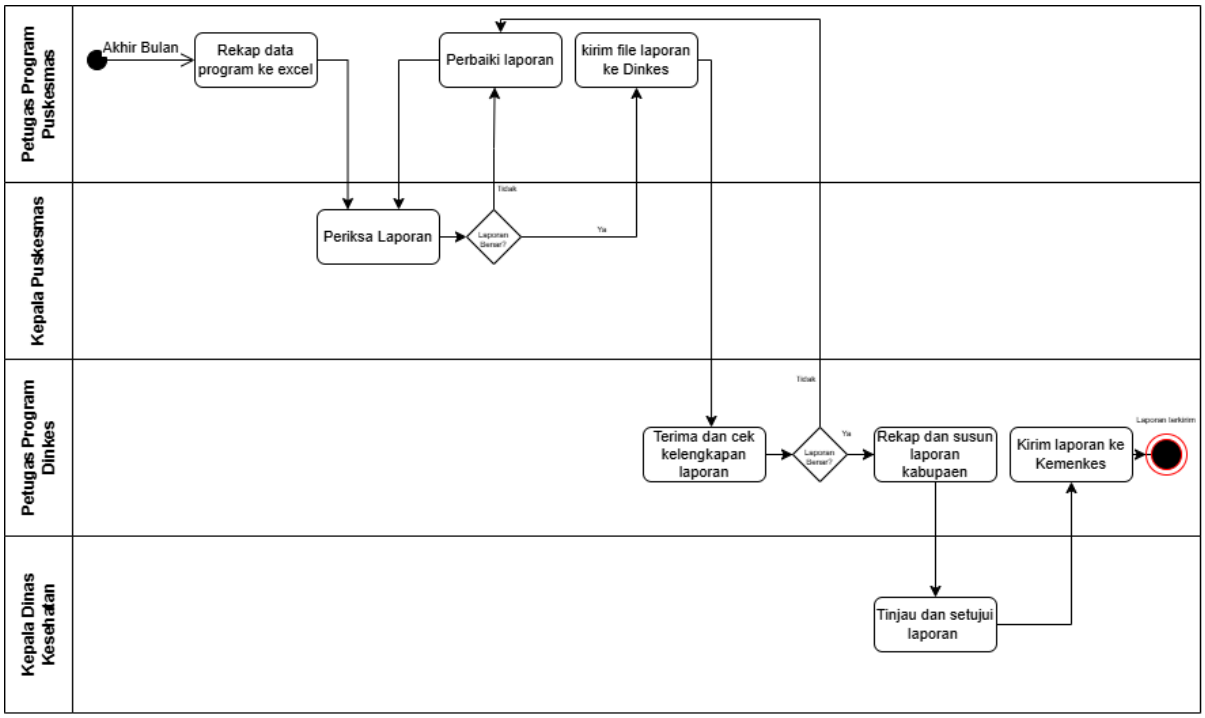



*Gambar 5.2 Value Stream Pelayanan Kesehatan Masyarakat sampai Pengambilan Keputusan*

Value stream ini menggambarkan bagaimana nilai dihasilkan, mulai dari perencanaan program sampai Kepala Dinas mengambil keputusan. Enam tahap dibuat berdasarkan alur kerja Puskesmas dan Dinkes, lengkap dengan stakeholder dan hasil tiap tahap. Hambatan terbesar ada di tahap pelaporan Puskesmas dan rekap kabupaten karena laporan masih manual dan terpisah per program, sehingga data baru sampai ke Kepala Dinas setelah melewati banyak tahap.

Penjelasan BPMN: Proses yang dipilih adalah pelaporan program kesehatan bulanan karena berhubungan langsung dengan masalah utama di Modul 1. Model memakai empat lane, yaitu Petugas Program Puskesmas, Kepala Puskesmas, Petugas Program Dinkes, dan Kepala Dinas Kesehatan. Proses dimulai di akhir bulan saat petugas merekap data program ke Excel. Kepala Puskesmas memeriksa laporan, dan kalau belum benar, laporan dikembalikan untuk diperbaiki. Setelah benar, file dikirim ke Dinkes. Petugas Dinkes mengecek kelengkapan. Kalau belum lengkap, laporan diminta diperbaiki lagi, dan kalau sudah lengkap, data semua Puskesmas direkap menjadi laporan kabupaten. Laporan ditinjau dan disetujui Kepala Dinas, lalu dikirim ke Kemenkes.

## 3. Model BPMN : Pelaporan Program Kesehatan




*Gambar 5.2 BPMN Proses Pelaporan Program Kesehatan Bulanan (kondisi saat ini*

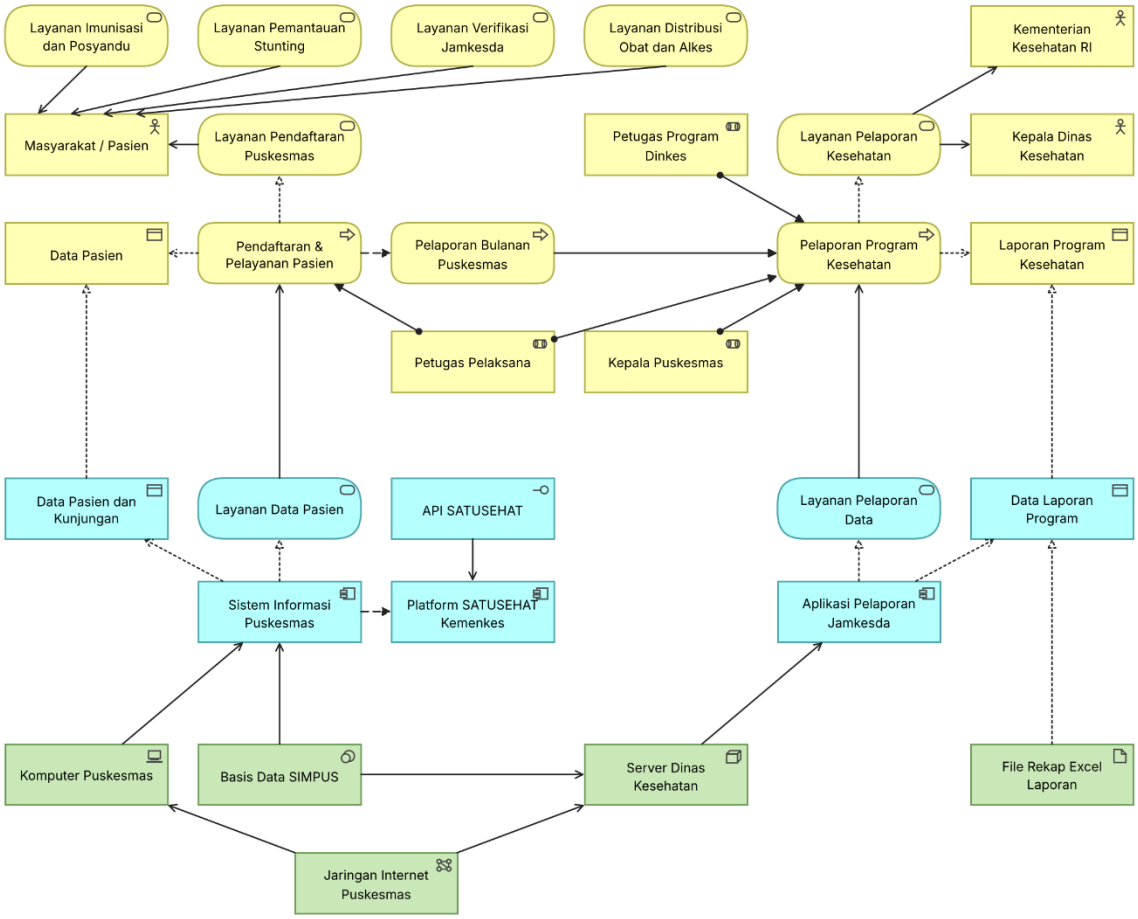
## 4. Katalog Layanan Bisnis

### Tabel 5.2 Katalog Layanan Bisnis

| Layanan | Penyedia | Pengguna | Proses pendukung |
|---|---|---|---|
| Layanan Pendaftaran Puskesmas | Puskesmas | Masyarakat | Pendaftaran dan Pelayanan Pasien |
| Layanan Pemeriksaan dan Pengobatan | Puskesmas | Masyarakat | Pendaftaran dan Pelayanan Pasien |
| Layanan Imunisasi dan Posyandu | Puskesmas dan Posyandu | Ibu dan anak | Pencatatan data imunisasi |
| Layanan Pemantauan Stunting | Puskesmas dan Bidang terkait | Balita dan keluarga | Pencatatan data gizi balita |
| Layanan Verifikasi Jamkesda | Dinas Kesehatan | Peserta Jamkesda, Puskesmas | Pelaporan Jamkesda |
| Layanan Distribusi Obat dan Alkes | Gudang Farmasi Dinas | Puskesmas | Pengelolaan stok obat |
| Layanan Pelaporan Kesehatan | Dinas Kesehatan | Kepala Dinas, Kemenkes | Pelaporan Program Kesehatan |

## 5. Penambahan ke Model Archi

Elemen bisnis dari modul ini ditambahkan ke model Archi dari Modul 4. Sebagian elemen sudah ada (misalnya Masyarakat/Pasien, Kepala Dinas, Petugas Pelaksana, Layanan Pendaftaran Puskesmas, dan Layanan Pelaporan Kesehatan). Elemen yang ditambahkan adalah sebagai berikut.




**Tabel 5.3 Elemen Bisnis Tambahan pada Model Archi**

| Elemen | Jenis Elemen | Terkait dengan |
|---|---|---|
| Kepala Puskesmas | Business Role | Pelaporan Program Kesehatan |
| Petugas Program Dinkes | Business Role | Pelaporan Program Kesehatan |
| Kementerian Kesehatan RI | Business Actor | Pelaporan Program Kesehatan |
| Layanan Imunisasi dan Posyandu | Business Service | Imunisasi |
| Layanan Pemantauan Stunting | Business Service | Penanganan Stunting dan Gizi |
| Layanan Verifikasi Jamkesda | Business Service | Jaminan Kesehatan Daerah |
| Layanan Distribusi Obat dan Alkes | Business Service | Pengelolaan Obat dan Alkes |
| Pelaporan Bulanan Puskesmas (langkah dari BPMN) | Business Process | Pelaporan Program Kesehatan |

## C. Analisis dan Pembahasan

Dari capability map terlihat ada empat capability dengan kematangan paling rendah (level 1) dan prioritas tinggi, yaitu Pelaporan Program Kesehatan, Manajemen Data Kesehatan, Integrasi dan Interoperabilitas, serta Tata Kelola TI dan Arsitektur. Keempatnya cocok dengan masalah di Modul 1 dan Modul 2, yaitu laporan manual, data belum seragam, aplikasi tidak terhubung, dan belum ada dokumen arsitektur. Karena itu investasi TI sebaiknya difokuskan dulu ke empat capability ini.

Sebaliknya, capability seperti Keuangan dan Anggaran serta Kepegawaian dan Umum sudah berjalan cukup baik (level 3) dan prioritasnya rendah, jadi tidak perlu investasi besar pada tahap awal. Pada value stream, hambatan terbesar ada di tahap pelaporan Puskesmas dan rekap kabupaten.

Dari BPMN terlihat beberapa masalah. Pertama, data direkap ulang ke Excel padahal sudah dicatat di aplikasi, sehingga ada kerja ganda. Kedua, ada dua kali pengembalian laporan (perbaikan di Puskesmas dan pengecekan di Dinkes) yang membuat prosesnya lama. Ketiga, pengiriman file dilakukan manual sehingga rawan salah versi dan terlambat. Kepala Dinas baru menerima laporan di tahap akhir, jadi keputusan saat keadaan darurat kesehatan bisa terlambat.

Kendala dalam pengerjaan adalah menentukan tingkat kematangan dan prioritas tanpa data resmi, sehingga penilaian didasarkan pada kondisi yang sudah ditemukan di modul sebelumnya. Keputusan yang diambil adalah memilih proses pelaporan program kesehatan untuk BPMN karena paling berkaitan dengan tujuan strategis nomor 1 dan 2.

## D. Jawaban Pertanyaan Evaluasi

### 1. Mengapa capability lebih stabil dibandingkan proses atau struktur organisasi?

Karena capability menjelaskan apa yang perlu dilakukan organisasi, bukan siapa yang melakukan atau bagaimana caranya. Proses bisa berubah kalau ada teknologi baru, dan struktur organisasi bisa berubah kalau ada peraturan baru. Contohnya, Dinkes tetap membutuhkan kemampuan Pelaporan Program Kesehatan, baik laporannya lewat Excel maupun lewat aplikasi, dan baik bidangnya berganti nama maupun tidak.

### 2. Bagaimana capability map membantu menentukan prioritas investasi TI?

Capability map menunjukkan capability mana yang penting dan seberapa matang kondisinya. Capability yang penting tetapi kematangannya rendah menjadi prioritas investasi, contohnya Pelaporan Program Kesehatan dan Integrasi. Capability yang sudah matang atau kurang penting tidak perlu investasi besar. Dengan begitu anggaran TI yang terbatas bisa dipakai pada hal yang paling berdampak.

## E. Kesimpulan

Pada Modul 5 sudah disusun capability map tiga tingkat dengan 18 capability, value stream enam tahap, satu model BPMN dengan empat lane, serta katalog aktor dan layanan bisnis Dinas

Kesehatan Kabupaten Cianjur. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaporan program, manajemen data, integrasi, dan tata kelola TI adalah bagian yang paling perlu diperbaiki. Ini menjadi dasar untuk arsitektur data, aplikasi, dan teknologi pada modul berikutnya.

## F. Lampiran

Berkas model Archi yang sudah diperbarui: M05_Farhana_Wahidiyah.archimate (diunggah bersama laporan ini).